KAŽDÝ TÝDEN JEDEN PŘÍPAD™ · BONUS 3

Šablony prezentace případu kolegům

Hotové struktury, šablony s hranatými závorkami a kontrolní seznam dokumentace, abyste případ přehledně představili za 60 sekund, za 5 minut nebo na posteru.

Bible ortodontisty

Obsah

Před prezentací: čtyři pravidla

Prezentace za 60 sekund

Prezentace za 5 minut

Posterová prezentace

Písemná žádost kolegy o názor

Kontrolní seznam dokumentace: fotografie, modely, RTG snímky

Srovnání před / po

Časté chyby při prezentaci

Další krok

NA ÚVOD

Před prezentací: čtyři pravidla

Stejná kostra bez ohledu na formát.

1. **Stanovte jednu otázku.** „Co od vás u tohoto případu chci?“ Názor, rozhodnutí, nebo výuku? První i poslední věta prezentace se váže k této otázce.
2. **Používejte stejné pořadí.** Údaje o pacientovi a stížnost → nálezy → seznam problémů → plán → otázka nebo závěr.
3. **Pacienta anonymizujte.** Odstraňte identifikátory jako jméno, číslo karty a data. U fotografií obličeje se řiďte formulářem souhlasu, který používá vaše pracoviště.
4. **Dokumentace ať je standardizovaná.** Stejný úhel, stejné světlo, stejné pořadí. Kontrolní seznam dokumentace odškrtejte před prezentací.

FORMÁT	KDY	HLAVNÍ CÍL
60 sekund	Krátká konzultace na pracovišti, rozhovor na chodbě	Získat názor k jedinému rozhodnutí
5 minut	Seminář o případech, studijní skupina	Prodiskutovat plán nebo představit dokončený případ
Poster	Kongresy a odborné akce	Učinit případ srozumitelným na první pohled

FORMÁT 1

Prezentace za 60 sekund

Čtyři bloky, každý o jedné až dvou větách.

ČAS	BLOK	OBSAH
0–10 s	Údaje o pacientovi a stížnost	Věk, pohlaví, fáze růstu, stížnost vlastními slovy pacienta.
10–30 s	Hlavní nálezy	Molárový vztah / vztah špičáků, overjet/overbite, stěsnání, dvě tři kefalometrické hodnoty, důležitá anamnéza.
30–45 s	Problém a možnosti	Nejdůležitější problém a dvě možnosti, které zvažujete.
45–60 s	Otázka	Co přesně od kolegy chcete.

Šablona

[Věk] let, **[fáze růstu]**, **[dívka / chlapec / žena / muž]**. Stížnost: „**[věta pacienta]**“.

Molárový vztah **[vpravo / vlevo]**, overjet **[mm]**, overbite **[mm]**. Stěsnání nahoře **[mm]**, dole **[mm]**. ANB **[°]**, FMA **[°]**. Důležitá anamnéza: **[zlozvyk / trauma / celkový zdravotní stav]**.

Hlavní problém je podle mě **[problém]**. Zvažuji dvě možnosti: **[možnost 1]**, nebo **[možnost 2]**.

Chtěl/a bych se vás zeptat: **[jedna jasná otázka]**?

Vyplněný příklad (smyšlený)

Chlapec, 13 let, blízko pubertálního růstového spurtu. Stížnost: „Zuby mi trčí dopředu.“

Molárový vztah oboustranně II. třída o celou šířku zubu, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Stěsnání nahoře 4 mm, dole 3 mm. ANB 6°, FMA 25°. Před rokem fraktura korunky horního centrálního řezáku v anamnéze.

Hlavní problém je podle mě II. třída na podkladě mandibulární retruze a zvětšený overjet. Zvažuji dvě možnosti: začít funkčním aparátem, nebo po ukončení růstu kamufláž s extrakcí.

Chtěl/a bych se vás zeptat: Začali byste u tohoto pacienta s traumatem v anamnéze s funkčním aparátem už teď?

FORMÁT 2

Prezentace za 5 minut

10 snímků, celkem asi 5 minut. Na každém snímku jedna myšlenka.

SNÍMEK	ČAS	NADPIS	OBSAH
1	30 s	Nadpis a otázka	Název případu a jediná otázka nebo hlavní sdělení prezentace.
2	30 s	Údaje o pacientovi a stížnost	Věk, fáze růstu, stížnost, relevantní anamnéza.
3	40 s	Extraorální fotografie	En face v klidu, en face s úsměvem, profil. Hodnocení profilu jednou větou.
4	40 s	Intraorální fotografie	Zepředu, vpravo, vlevo, horní a dolní okluzní. Nálezy v okluzi postupně.
5	30 s	RTG snímky	Nálezy na OPG (v pořadí podle Nástroje 1) a laterální kefalogram.
6	30 s	Kefalometrické shrnutí	Osm měření a interpretace ve třech větách: sagitálně, vertikálně, dentálně.
7	30 s	Seznam problémů	Sagitálně, vertikálně, transverzálně, prostor a stížnost pacienta.
8	30 s	Cíle a plán	Cíle, možnosti a zvolený plán; zdůvodnění.
9	20 s	Průběh nebo výsledek	U probíhajícího případu aktuální fáze; u dokončeného případu před/po.
10	20 s	Otázka nebo poučení	Otázka do diskuse nebo jedno poučení z tohoto případu.

Snímek se seznamem problémů · šablona

Sagitálně: [molárový vztah / vztah špičáků, overjet, skeletální zdroj]

Vertikálně: [overbite, vertikální typ]

Transverzálně: [zkřížený skus, střední čáry]

Prostor: [stěsnání/mezery nahoře a dole, mm]

Stížnost pacienta: [věta pacienta]

Snímek s plánem · šablona

Cíle: 1) [cíl] 2) [cíl] 3) [cíl]

Možnosti: A) [možnost] · B) [možnost]

Zvolený plán a zdůvodnění: [plán], protože [zdůvodnění].

Kotvení a retence: [plán kotvení] · [plán retence]

FORMÁT 3

Posterová prezentace

Tak málo textu, aby se dal přečíst z metru, a takové uspořádání, aby byl srozumitelný na první pohled.

Nadpis

[Nadpis, který vystihne případ jednou větou] · [Název instituce nebo pracoviště ve formě, kterou požaduje akce]

Úvod

[Proč je případ zajímavý, 2–3 věty]

Údaje o případu

[Věk, stížnost, anamnéza; extraorální a intraorální fotografie]

Diagnóza

[Tabulka kefalometrického shrnutí a seznam problémů]

Plán

[Cíle, možnosti a zvolený plán]

Průběh léčby

[Fáze a délka; průběžné fotografie]

Výsledek

[Fotografie před / po, srovnání závěrečné kefalometrie]

Diskuse a poučení

[2–3 poučení z tohoto případu; stručně a konkrétně]

Kontrolní seznam posteru

- [ ] Přečetl/a jsem pravidla akce pro rozměr a formát.
- [ ] Každá sekce má nejvýše několik krátkých vět.
- [ ] Fotografie ve stejném úhlu a světle, před/po vedle sebe.
- [ ] Kefalometrické hodnoty jsou v tabulce, v textu se neopakují.
- [ ] Identifikátory pacienta jsou odstraněny; souhlas byl získán formulářem, který používá vaše pracoviště.
- [ ] Nadpis je čitelný z dálky.

ŠABLONA

Písemná žádost kolegy o názor

Krátká, uspořádaná zpráva zaměřená na jednu otázku dostane rychlejší a jasnější odpověď.

Kolegovi ortodontistovi

Vážený pane kolego / Vážená paní kolegyně **[jméno kolegy]**,

prosím vás o krátký názor na jeden případ. Pacient, **[věk]** let, **[fáze růstu]**. Hlavní nálezy: **[molárový vztah, overjet, overbite, stěsnání]**; ANB **[°]**, FMA **[°]**.

Váhám mezi dvěma možnostmi: **[možnost 1]** a **[možnost 2]**. Přikláním se k možnosti **[možnost]**, protože **[zdůvodnění]**.

Moje otázka: **[jedna otázka]**? Anonymizovanou dokumentaci přikládám.

Děkuji, **[vaše jméno]** · **[název pracoviště]**

Konziliární zpráva pro chirurga, parodontologa nebo protetika

Pacient: **[kód karty]**, **[věk]** · **Důvod konzilia:** **[např. posouzení chirurgické možnosti / potvrzení parodontální stability / plán místa pro implantát]**

Ortodontické nálezy: **[stručné shrnutí]**

Ortodontický plán: **[plánované pohyby zubů a předpokládané fáze]**

Co od vás očekáváme: **[jasná otázka nebo souhlas]**

Přílohy: **[fotografie, RTG snímky, kefalometrické shrnutí]**

KONTROLNÍ SEZNAM

Kontrolní seznam dokumentace

Stejný seznam při každé vstupní, průběžné i závěrečné dokumentaci. Před prezentací doplňte, co chybí.

Extraorální fotografie

- [ ] En face, v klidu
- [ ] En face, s úsměvem
- [ ] Profil, v klidu
- [ ] Úsměv v tříčtvrtečním pohledu
- [ ] Podle potřeby zespodu (kvůli asymetrii)

Intraorální fotografie

- [ ] Zepředu, v okluzi
- [ ] Pravá bukální
- [ ] Levá bukální
- [ ] Horní okluzní
- [ ] Dolní okluzní
- [ ] Pohled na overjet (z boku)

Modely

- [ ] Úplný záznam horního a dolního oblouku (digitální nebo sádrový)
- [ ] Registrát okluze
- [ ] Podle potřeby registrát v centrální relaci
- [ ] Výsledky analýzy prostoru a Boltonovy analýzy

RTG snímky

- [ ] OPG (hodnocený v pořadí podle Nástroje 1)
- [ ] Laterální kefalogram a jeho obkreslení
- [ ] Doplňkové zobrazení podle indikace
- [ ] Průběžné a závěrečné snímky

Standard fotografií

- [ ] Stejné pozadí a světlo; bez odlesků.
- [ ] Hlava v přirozené poloze, na profilové fotografii Frankfurtská horizontála přibližně rovnoběžně s podlahou.
- [ ] U intraorálních fotografií stejné použití retraktorů a zrcátek při každé dokumentaci.
- [ ] V názvech souborů žádné jméno pacienta; kód karty vašeho pracoviště a fáze dokumentace (vstupní / průběžná / závěrečná).

PREZENTACE VÝSLEDKU

Srovnání před / po

Stejné podmínky, aby změna byla ukázána poctivě.

PRAVIDLO	PROČ
Stejný úhel a stejné zvětšení	Jiný úhel může změnu zveličit nebo skrýt.
Stejné světlo a pozadí	Rozdíl v barvě a kontrastu působí jako změna.
Vedle sebe nebo nad sebou	Divák by měl mít možnost srovnat si to sám.
Kefalometrické hodnoty uveďte v tabulce	Vstupní, závěrečná hodnota a rozdíl ve třech sloupcích.
Uveďte omezení	Když napíšete i cíle, kterých se nepodařilo dosáhnout, je prezentace důvěryhodná.

Tabulka kefalometrického srovnání · šablona

MĚŘENÍ	VSTUPNÍ	ZÁVĚREČNÉ	ROZDÍL
SNA			
SNB			
ANB			
Wits			
FMA			
SN-GoMe			
IMPA			
U1-SN			

ČEMU SE VYHNOUT

Časté chyby při prezentaci

Ke každé oprava v jedné větě.

CHYBA	OPRAVA
Schovat otázku až na konec	Otázku řekněte v první větě a zopakujte ji v poslední.
Přečíst všechny kefalometrické hodnoty	Osm měření v tabulce, ústně pouze interpretace ve třech větách.
Přeskočit seznam problémů a začít aparátem	Nejdřív seznam problémů a cíle, potom mechanika.
Fotografie před/po v různém úhlu a světle	Kontrolní seznam dokumentace uplatněte hned na začátku.
Nechat identifikátory pacienta na snímku	Před prezentací zkontrolujte vše, včetně názvů souborů.
Prezentovat jen úspěšné případy	Prezentace zaseknutého případu bývá často poučnější.
Překročit čas	Jednou si to nahlas vyzkoušejte se stopkami.

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Vyberte si tento týden jeden případ a vyplňte šablonu na 60 sekund. Případy z **Týdnů 49–52** v 52týdenním programu práce s případy se k nácviku prezentace hodí ideálně.

Pro snímek s kefalometrickým shrnutím použijte metodu tří vět z **Cvičebnice kefalometrických měření**. Pro seznam problémů a plán otevřete v Bibli ortodontisty **Nástroj 4 · Klinický plánovač ve 4 krocích**.